جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : تهانى محمد حامد راغب

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الاخصاص **العنوان :** ---

رقم البطاقة : 27811280102725 **رقم التليفون :** 01120575104 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 28-11-1978 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(--------------------------) **التوقيع:(--------------------------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : --------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** د/محمد كيلاني

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** د/ندى حسن

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** نرمين رمضان

G R I - E
جوستاف روسي
جوستاف روسي مصر

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ------------------------ **ا.د/** ------------------------ **د/** ------------------------ **د/** ------------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --

خطة العلاج : --

المستشفي : -- **قسم :** --

جهة العلاج : -- **نفقات :** --

ملاحظات : --

رئيس **المجلس الطبي المتخصص**	**مدير عام** **مديرية الشئون الصحية**	**ختم** **شعار الجمهورية**

Name: تهانى محمد حامد راغب
National ID: 27811280102725

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

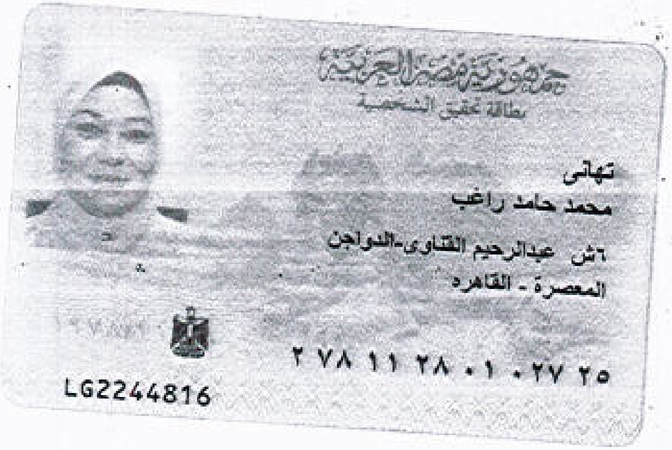
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : yyyy-mm-dd --:-- --	تاريخ وساعة الخروج : 05-07-2026 01:17 PM

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : **05-07-2026**	الوقت : **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

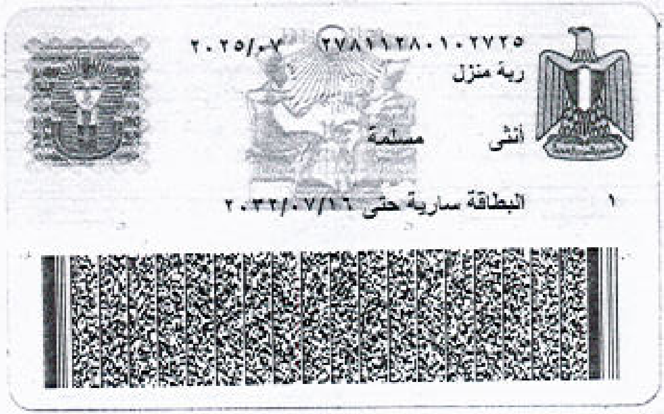


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

تهانى
محمد حامد راغب
٦ش عبدالرحيم القناوى-الدواجن
المعصرة - القاهره

٢ ٧٨ ١١ ٢٨ ٠١ ٠٢٧ ٢٥

LG2244816



٢٧٨١١٢٨٠١٠٢٧٢٥ ٢٠٢٥/٠٧
ربة منزل
أنثى مسلمة
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٧/١٦

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name : الأستاذه / تهاني محمد حامد راغب
Patient No. : 27811280102725
Path No. : 2693/25
Sex : Female
Age : 46 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13006027
Request Date : 01/09/2025
Verification Date : 08/09/2025
Financial Category : جوستاف روسي - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast LIQ mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy.

Gross Examination:
- Six grey white tissue cores, the longest was 1 cm. Totally submitted.

Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
* Histological type: Mixed invasive lobular & invasive duct carcinoma.
* Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
* DCIS: Absent.
* LCIS: Absent.
* ngioinvasion: Absent.
rineural invasion: Absent.

* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 60%.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Mixed invasive lobular & invasive duct carcinoma, Grade 2.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: تهاني محمد حامد
MR. : 1613

GUSTAVE ROUSSY

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من

بشأن تقرير طبي للمريض

بقسم:

رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :

تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

t1c n1a 12/2025 mdt :adjuvant :ac*4+taxwol *12+porth+ai+zoladex 31/1/2026:c2 ac protocol

46 y wt 86 ht 163 sa 1.7 prem left breast cancer lt bcs on 3/11/2025 t1 n1/13 er8/8 pr8/8 her2-ve ki 60% for c3 ac adria 100 endoxan 1000

Pt came today for C4 AC adria 100 , endoxan 1000 labs >>> oK

ADJUVANT :TAXWOL *12 WEEKELY . TODAY :W1 TAXSOL (W2 AND W 3 IN PH)

for wk 7, 8, 9 taxol after labs - dont give supp ttt w9 with cbc

week 8 today taxol only with DR 10% , PN GRADE II week 9 TAXOL WITH CBC , 10 pharmacy TAXOL

for week 10 taxol (dr 10%) week 11 and 12 pharmacy

Pharmacy Visit For W12 Taxol 120 mg (10% DR) Labs 16/6 ... accepted

CT2 N0, pT1C N1a (upfront LT CBS + SLNB) adj CTH, PORT AI/ZOLADEX for 5 yr pt finished adj cth, pending PORT, for adj femara for BSM 16/6/2026 FREE

تحريرا في ,

التاريخ : 19-09-2026

الوقت :

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

نتيجة العينة

Patient Name : الأستاذه / تهاني محمد حامد راغب
Patient No. : 27811280102725
Path No. : 3356/25
Sex : Female
Age : 46 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13000953
Request Date : 03/11/2025
Verification Date : 29/11/2025
Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

* Angioinvasion: Present.
* Perineural invasion: Absent.
* Surgical margins: Free.
* Sentinel lymph nodes: Positive metastatic deposit in one out of three sentinel lymph nodes (1/3) with extra-nodal extension.
* Completion axillary lymph nodes: Free ten lymph nodes (0/10).
* Total nodal status: Positive metastatic deposits in one out of thirteen lymph nodes (1/13) with extra-nodal extension.

Diagnosis:
Left breast cancer (Up-front), Left breast conservative surgery, Sentinel lymph nodes biopsy& Completion axillary clearance:
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- Surgical margins: Free.
- Total lymph nodal status: Positive metastatic deposit in one out of thirteen lymph nodes (1/13) with extra-nodal extension.
- Stage: pT1c, pN1a.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient ID: 27811280102725	Patient Name English: Tahany Mohamed Hamed Ragheb
Age:46 years	2025/10/14 10:48:10 AM :Report Date

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: Known case of left mixed invasive ductal and lobular carcinoma

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: minimal background enhancement

ACR: b (scattered fibro-glandular densities)

LEFT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) Images:** Inner central irregular dense spiculated mass lesions.
- **Recombined (Post contrast) images:** Inner central irregular intense hetregenously enhancing mass measures 3.2c2c2.1cm located 1.5cm from nipple.
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary US:** 8-9:00 irregular hypoechoic mass lesion
- Non specific axillary lymphnodes

RIGHT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images** No masses, asymmetry or distortion or suspicious microcalcifications.
- **Recombined (Post contrast) images** show, no pathological uptake.
- Normal skin / nipple / areolar complex.

IMPRESSION:

LEFT BREAST: (BIRADS6 =pathologically proved malignancy):8-9:00 unifocal enhancing malignant mass lesion as described

RIGHT BREAST: (BIRADS 1= Normal)

Best regards,

Dr. Marwa Ramzy, MD, FRCR

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name: Tahany Mohamed Hamed Ragheb	Date : 17/09/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 2149/2025	Pat. ID: 111527

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Left breast UIQ irregular spiculated mass lesion 18 x 13 mm.
- Left axillary enlarged L. Ns , the largest measures 24 x8 mm.
- Small middle lobe lateral segment nodule 3mm likely post granulomatous.
- o sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
  No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers.
  No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is mildly enlarged with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities .
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with dense calcific foci likely poost granulomatous
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
  Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Right pubic bone subchondral lytic lesion likely part of OA changes

Opinion:

Reported case of left breast cancer:

- **No pulmonary , hepatic ometastastic deposits .**
- **Right pubic bone subchondral lytic lesion likely part of OA changes**

Dr. Reham Khedr, M.D
Signature Reeham.Khader
19/09/2025 1:44 AM

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

NILE SCAN & LABS مسح د. رى ركز النيل للأشعة و التحاليل

Name : Tahani Mohammed Hamid Ragheb Date : 29.09.2025 09:52
Branch : Dokki Medical No.: 213551

Tc^{99}m MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

- A 46-year-old lady, with history of left breast cancer and referred for metastatic workup.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings

- No abnormal active or cold focal bony lesions that could account for metastatic bone disease.
- Degenerative changes are noted at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

Cell Center [illegible]

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

مستشفيات جامعة القاهرة
إدارة الخدمات الاجتماعية
مركز قصر العيني لعلاج الأورام
والطب النووي

٨٨٩
٥/١٠/٢٠٢٦

تقرير طبي بالخدمات الاجتماعية الطبية

اسم المريض : م هاني محمد حامد السن : ٤٦ المهنة : لا تعمل القسم : ٧٩٦٩

رقم المستشفى : V969. تاريخ الدخول / / ٢٠ تاريخ الخروج / / ٢٠

مازال تحت العلاج

التشخيص : المريضة المذكورة تعاني من ورم خبيث بالثدي الايسر وقد أجرت الاستئصال

التوصيات : الجراحي ثم تلقت العلاج الاشعاعي بعد الجراحة من فترة ١٣/٩/٢٠٢٦م الى فترة ٥/١٠/٢٠٢٦م بواقع

Care of Lt. Breast IDC (40GY/15fr)

G2 ER, PR+ve, Her2-ve, received PORTH.

مشرفة القسم

الطبيب المعالج
ط م/ دينا عاطف

تحريراً في ٥/١٠/٢٠٢٦

السيد الأستاذ / مدير مستشفى جوستاف روسي

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم التقرير الطبي للمريض المذكور .

برجاء التكرم باتخاذ اللازم نحو مساعدته دون أدنى مسئولية على المستشفى .

الأخصائي الاجتماعي

مدير الخدمة الاجتماعية

المدير

٥

٢٠٢٦

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]